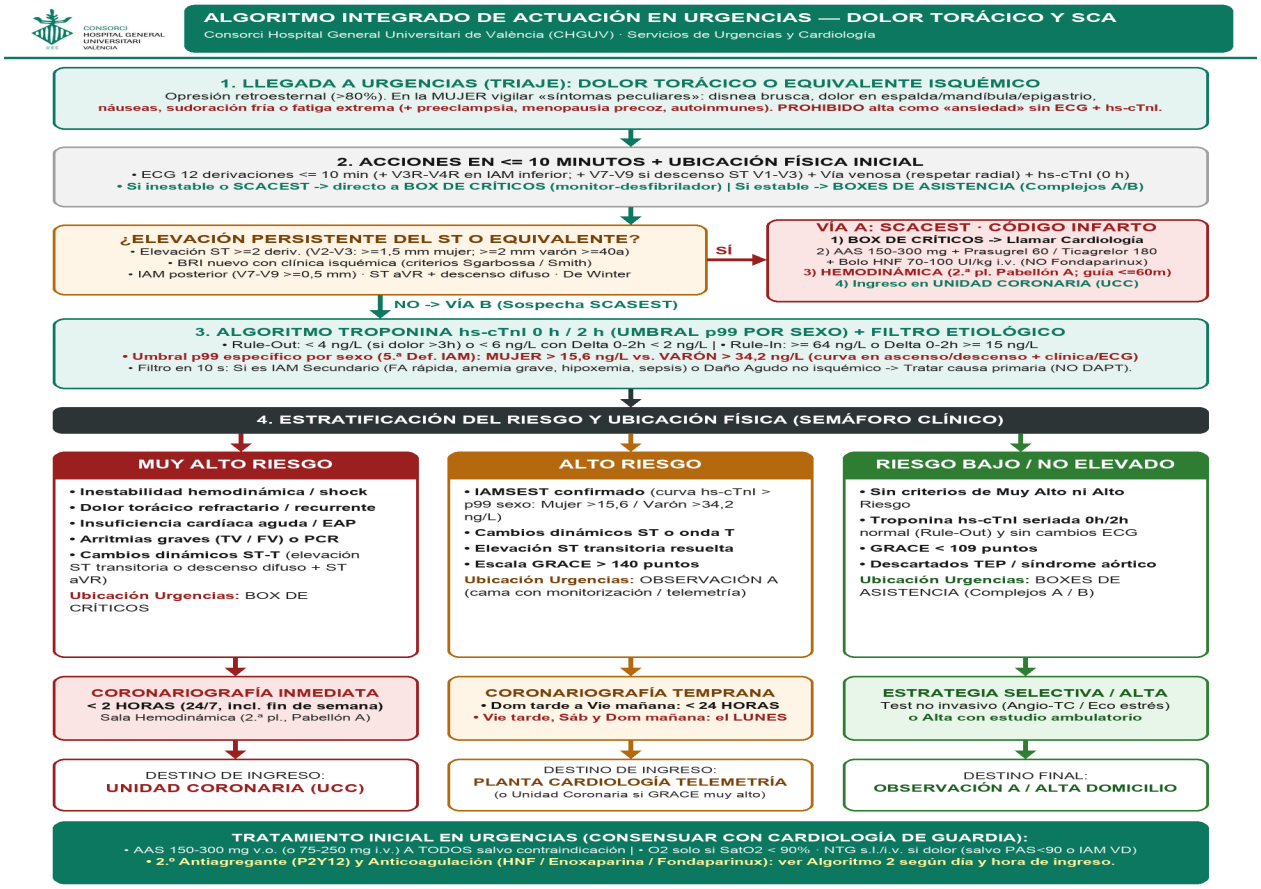
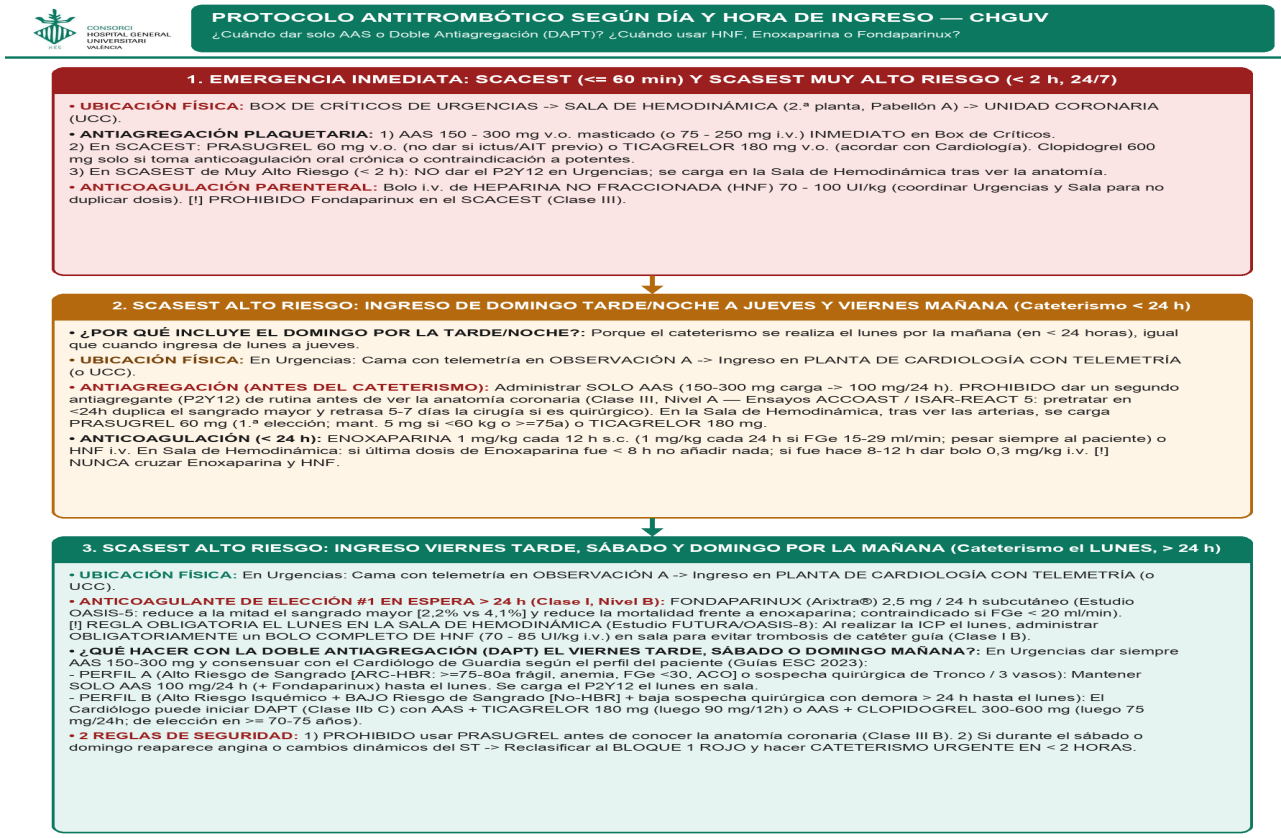
GUÍA OPERATIVA INTEGRADA DE ACTUACIÓN EN URGENCIAS Y CARDIOLOGÍA: DOLOR TORÁCICO Y SCA

Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV) · Resumen Ejecutivo de Acceso Inmediato (Semáforo Clínico, Ubicación y Fármacos)

SEMÁFORO Y ESCENARIO	UBICACIÓN FÍSICA CHGUV	ANTIAGREGACIÓN	ANTICOAGULACIÓN Y REGLA EN SALA
ROJO — 1A. SCACEST o Equivalente Código Infarto (ICP < 90 min)	**BOX DE CRÍTICOS** → **SALA HEMODINÁMICA** → **UCC**	• **AAS 300 mg** v.o. (o 150-250 mg i.v.). • **Prasugrel 60 mg** o **Ticagrelor 180 mg** (Clopidogrel 600 mg en ≥75a o ACO).	• **Bolo HNF 70-100 UI/kg i.v.** • **PROHIBIDO Fondaparinux** en SCACEST.
ROJO — 1B. SCASEST MUY ALTO RIESGO Inestable, dolor refractario, EAP, TV/FV	**BOX DE CRÍTICOS / OBS. A** → **SALA HEMODINÁMICA (< 2 h)** → **UCC**	• **SOLO AAS 300 mg**. • **NO dar 2.º antiagregante** en Urgencias; se carga en Sala.	• **Bolo HNF 60-70 UI/kg i.v.** (máx 5.000 UI) para ICP emergente (< 2 h).
ÁMBAR — 2A. SCASEST ALTO RIESGO **Dom tarde a Jueves y Vie mañana** (< 24 h)	Monitorizar en **OBSERVACIÓN A** y comentar con Cardiólogo → **PLANTA TELEMETRÍA / UCC**	• **SOLO AAS 300 mg**. • **PROHIBIDO P2Y12 pre-cate** (Clase III A). Se carga en Sala tras ver anatomía.	• **Enoxaparina s.c.**: 1 mg/kg/12h (<75a); 0,75 mg/kg/12h (≥75a); HNF i.v. si FGe < 30. • No cruzar con HNF.
VERDE/ÁMBAR — 2B. SCASEST ALTO RIESGO **Vie tarde, Sáb y Dom mañana** (Cate Lunes)	Monitorizar en **OBSERVACIÓN A** y comentar con Cardiólogo → **PLANTA TELEMETRÍA / UCC**	• **AAS 300 mg**. • Si ≥75a, HBR o sospecha Qx: **SOLO AAS**. • Si <75a No-HBR + NSTEMI: valorar **Ticagrelor 180 mg / Clopidogrel**. Nunca Prasugrel.	• **1.ª Elección: FONDAPARINUX 2,5 mg/24h s.c.** (reduce 48% sangrado mayor). • **EL LUNES EN SALA: Bolo obligatorio HNF 70-85 UI/kg i.v.**
VERDE — 3. BAJO RIESGO (Rule-Out) hs-cTnI 0h/2h ≤ p99 sin delta + HEART 0-3	**BOXES GENERALES URGENCIAS** → Alta directa (VPN > 99,5%)	• No precisa antiagregación aguda.	• No precisa anticoagulación.



Algoritmo 1 (CHGUV): Actuación integrada en Urgencias ante Dolor Torácico, diagnóstico diferencial por sexo y Semáforo de Riesgo.



Algoritmo 2 (CHGUV): Protocolo antitrombótico exacto según día y hora de ingreso (Domingo tarde a Viernes mañana vs. Viernes tarde, Sábado y Domingo mañana).

PASO 0 (FILTRO PREVIO OBLIGATORIO): TROPONINA ELEVADA SIN DOLOR TORÁCICO -> NO ES UN SCA TIPO 1

• **Regla de Oro CHGUV (5.ª Definición Universal de IAM y Guías ESC 2023):** Si el paciente **NO consulta por dolor torácico ni clínica anginosa** y presenta una **hs-cTnI > p99** (Mujer > 15,6 / Hombre > 34,2 ng/L) con ECG sin elevación del ST, se trata de un **Daño Miocárdico No Isquémico** o un **IAM Tipo 2**, **NUNCA de un SCA aterotrombótico (Tipo 1)**. En estos casos está **PROHIBIDO iniciar Doble Antiagregación (DAPT)** (multiplica el sangrado grave) y **NO se debe llamar de rutina al Cardiólogo de Guardia**.

Contexto Clínico (Sin Dolor Torácico)	Mecanismo (5.ª Def. IAM)	Qué Valorar y Hacer (Sin Activar Protocolo SCA)
1. Taquiarritmia (FA rápida, TSV) o bradiarritmia	IAM Tipo 2 / Daño secundario	Controlar FC o revertir arritmia y repetir ECG tras frenar FC. **NO dar DAPT ni pedir cateterismo urgente.**
2. Sepsis, Neumonía, EPOC agudizado o Hipoxemia	Daño Miocárdico Agudo / IAM Tipo 2	Oxigenoterapia, antibioterapia precoz y soporte hemodinámico. Contraindicada DAPT y heparina de SCA.
3. Insuficiencia Cardíaca Aguda / EAP	Daño Miocárdico por sobrecarga parietal	Diuréticos i.v., vasodilatadores, NT-proBNP y ecocardiograma reglado sin activar circuito de SCASEST.
4. Anemia severa, Hemorragia, Hipotensión o Crisis HTA	IAM Tipo 2 (desajuste oferta/demanda)	Transfundir si anemia, controlar sangrado o PA. **¡Dar DAPT o heparina agravará cualquier sangrado!**
5. Enfermedad Renal Crónica (ERC) / Cardiopatía previa	Daño Miocárdico Crónico (Δ < 20%)	Comparar con basales previas. Si variación 0h/2h < 20% sin dolor ni cambios ECG, descartar evento agudo.
6. TEP, Ictus agudo, Síncope o Rabdomiólisis	Daño Miocárdico Agudo no coronario	Si disnea/taquicardia → Dímero D / Angio-TC pulmonar (TEP). Si ictus → manejo neurológico sin DAPT de SCA.

PASO 1 Y 2: PACIENTE CON DOLOR TORÁCICO -> PARTICULARIDADES EN LA MUJER, ANGINA Y ESCALAS

• **Clínica de sospecha en la Mujer y en el Hombre:** El dolor opresivo retroesternal es el síntoma principal en ambos sexos, pero en la mujer se acompaña con alta frecuencia de irradiación a espalda interescapular, mandíbula, cuello o epigastrio, disnea brusca, náuseas, sudoración fría o fatiga extrema. En mujeres ≤ 55 años o en el periparto, sospechar siempre **Disección Coronaria Espontánea (SCAD)**. Aplicar siempre el umbral p99 de hs-cTnI específico por sexo: **Mujer > 15,6 ng/L** y **Hombre > 34,2 ng/L**.

• **Definición de Angina Típica y Angina Inestable:** La Angina Típica cumple 3 criterios: 1) Opresión/peso retroesternal; 2) Provocada por esfuerzo o estrés (o en reposo > 20 min); 3) Cede con reposo o NTG sublingual en < 5 min. Es **Angina Inestable** cuando aparece en reposo (> 20 min), es de reciente comienzo (*de novo*) o progresiva (*in crescendo*).

• **Regla Institucional en Dolor Torácico con Troponinas Negativas:** Un dolor torácico con hs-cTnI 0h/2h negativa y ECG normal **NUNCA ingresa solo por el GRACE** (la edad y la creatinina elevan el GRACE > 140 en ancianos sin SCA). Además, **Urgencias no ingresa directamente en Cardiología**: todo caso se comenta con el **Cardiólogo de Guardia**.

TABLA DE LA ESCALA HEART (0-10 PUNTOS) Y CASOS CLÍNICOS DE DECISIÓN EN URGENCIAS

Componente HEART	0 Puntos	1 Punto	2 Puntos
H — Historia Clínica	Poco sospechosa (punzante, pleurítico, postural)	Moderadamente sospechosa	Altamente sospechosa (Angina típica opresiva)
E — ECG (12 deriv.)	Completamente normal	Alteración inespecífica repolarización / HVI / BRI	Depresión significativa ST o inversión onda T
A — Edad (Age)	< 45 años	45 a 64 años	≥ 65 años
R — Factores Riesgo CV	Sin factores de riesgo conocidos	1 o 2 factores de riesgo CV	≥ 3 factores o enfermedad aterosclerótica previa
T — Troponina (hs-cTnI)	≤ límite p99 (Mujer ≤15,6 / Hombre ≤34,2 ng/L)	1 a 3 veces el límite normal p99	> 3 veces el límite normal p99

Caso Clínico en Urgencias	Escala Aplicable	Conducta Operativa en el CHGUV
CASO 1: Dolor no anginoso + ECG normal + hs-cTnI 0h/2h ≤ p99 sin delta	Rule-Out ESC 0h/2h + **HEART 0–3 pt** (No calcular GRACE)	• VPN > 99,5% y riesgo MACE < 1% → **ALTA DIRECTA SEGURA** desde Boxes Generales.
CASO 2: Dolor dudoso o Zona Gris bioquímica	**HEART 4–6 pt** + 3.ª hs-cTnI a las 3 h	• Observación, 3.ª troponina (3 h), Ecocardiograma y valorar **Angio-TC coronario** o test de isquemia.
CASO 3: Angina Inestable verdadera con hs-cTnI 0h/2h negativa	Clínica de Angina Inestable / **HEART ≥ 7 pt**. Calcular **GRACE** tras diagnosticarla.	• **Comentar siempre con el Cardiólogo de Guardia**. Si se confirma Angina Inestable con **GRACE > 140** → Alto Riesgo (Cateterismo < 24 h).
CASO 4: NSTEMI (curva hs-cTnI > p99) o descenso dinámico ST/T	Criterio directo de Alto Riesgo ESC 2023 (GRACE opcional pronóstico)	• Monitorizar en **Observación A** y **comentar con el Cardiólogo de Guardia** para ingreso y cateterismo (<24h o Lunes con Fondaparinux).

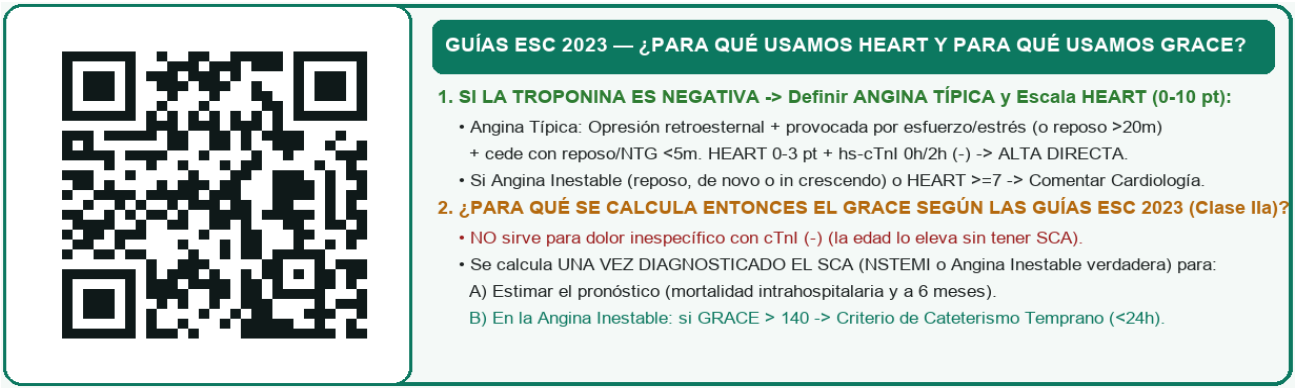


Figura 1B: Diferenciación práctica entre Escala HEART (troponina negativa) y Escala GRACE (SCA / Angina Inestable diagnosticada) con código QR.

PASO 5: GUÍA DE LA APLICACIÓN WEB INTERACTIVA DEL PROTOCOLO SCA CHGUV

• **Filtrado Progresivo Inteligente (Izquierda y Derecha sin Ruido Visual):** Al seleccionar el sexo biológico (Mujer vs. Hombre), el grupo de edad (< 75 vs. ≥ 75 años), el ECG y la situación clínica, desaparecen automáticamente tanto en el panel izquierdo como en el derecho todas las opciones, preguntas de troponinas/deltas y notas de fármacos que no corresponden a ese paciente.

• **Cuatro Pestañas Integradas: 1) Decisión Interactiva** (ubicación física en el CHGUV, dosis exacta de AAS/P2Y12/Fondaparinux/Enoxaparina/HNF y generador de nota clínica para copiar); **2) Escalas HEART y GRACE** (calculadoras interactivas conectadas al algoritmo); **3) Tabla Rápida de Guardia**; y **4) Descarga de Documentos PDF** (Protocolo Completo en PDF y Presentación Clínica en PDF).

• **Aviso Clínico (Disclaimer):** La aplicación y este protocolo tienen carácter orientativo basado en las Guías ESC 2023 y no sustituyen el juicio clínico individualizado del facultativo ni el comentario directo con el Cardiólogo de Guardia.